

ABD JALIL

04/08/1978 - 46 th 9 bln 17 hr

033172

PENGKAJIAN AWAL MEDIS NEUROLOGI

Riwayat Alergi	☒ Tidak ☐ Ya: Tidak Ada		
Kunjungan	Tanggal : 21-05-2025 Pukul : 15:56 WIB		
Anamnesis	☒ Auto anamnesis ☐ Allo anamnesis		
Anamnesis			
Keluhan Utama	Kejang sejak pasca operasi, sekarang 2 bulan bebas kejang. riwayat kejang kaku kelojotan. KLL 2bulan --> perdarahan --> di operasi.		
Riwayat Kesehatan	RPD: HT (-), DM (+)		
Riwayat Penggunaan Obat	lupa		
Kondisi Umum	☒ Sakit Ringan ☐ Sedang ☐ Berat ☐ Sesak GCS: 456		
Status Fisik			
Tanda Vital	TD : 120/80 mmHg Nadi : 97 x/mnt Suhu : 36 RR : 20 x/mnt		
Kondisi Nutrisi	☐ Obesitas ☐ Overweight ☒ Normoweight ☐ Underweight		
Kepala / Leher:	Anemis : -/- Ikterik : -/- Cyanosis : -/- Dyspnue : -/- Pembesaran KGB : -/-		
Thorax:	Gerak simetris (+), retraksi (-), normochest Cor : S1/S2 tunggal, reguler (+), gallop (-), murmur(-) Pulmo : Vesikuler : +/+, Rhonki : -/-, Wheezing : -/-		
Abdomen:	Soefl (+), BU(+) N, meteorismus (-), Nyeri tekan -/-/- -/-/- -/-/- Hepar : tidak teraba Lien : tidak teraba		
Ekstremitas:	Akral hangat, CRT <2 Edema -/- -/-		
Status Neurologis:	- GCS E4V5M6 - PBI 3mm/3mm, RC + +, RK + + - Meningeal sign Kaku kuduk (-), Brudzinski (-) - Nervus cr DBN - Sensorik + + - R. Fisiologis BPR +2 +2. KPR +2 +2 TPR +2 +2. APR +2 +2		
Pemeriksaan Penunjang			
Laboratorium	Radiologi	Pemeriksaan Lainnya	
-	-	-	
Diagnosis Medis	Utama: Epilepsy Sekunder: DM Type 2		

Permasalahan			
Medis	Kejang sejak pasca operasi, sekarang 2 bulan bebas kejang. riwayat kejang kaku kelojotan. KLL 2bulan --> perdarahan --> di operasi.		
Keperawatan	Hipertermia # Gejala dan tanda Minor: * Objektif: - Kejang		
Rencana Asuhan (Tetapi / Instruksi / Standing Order / Intervensi)			
PHENYTOIN SODIUM KAPS 100 MG - IKAPHARMINDO No. LX S2dd1 sesudah makan,Rute: Oral VITAMIN B6 TAB 10 MG - TRIFA No. XXX S1dd1 sesudah makan,Rute: Oral c/ bedah saraf medikasi			
Tolak ukur/ Sasaran yang akan dicapai: perbaikan			
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)			
Telah dilakukan edukasi tentang Pengkajian Awal Medis kepada: ☒ Pasien ☐ Keluarga pasien, nama: Hubungan dengan pasien: ☐ Tidak dapat memberi edukasi kepada pasien atau keluarga Karena	Pasien  ABD JALIL	Keluarga	Dokter  dr. Rachmawati Wardani Sp.N SIP.



ABD JALIL

04/08/1978 - 46 th 9 bln 2 hr

033172

PENGKAJIAN AWAL MEDIS BEDAH SYARAF

Riwayat Alergi	☒ Tidak ☐ Ya: Tidak Ada		
Kunjungan	Tanggal : 06-05-2025 Pukul : 16:09 WIB		
Anamnesis	☒ Auto anamnesis ☐ Allo anamnesis		
Anamnesis			
Keluhan Utama	kontrol post mrs nyeri kepala sakala 4 kejang kejang		
Riwayat Penyakit	Tidak Ada		
Riwayat Penggunaan Obat	Tidak Ada		
Kondisi Umum	☐ Sakit Ringan ☒ Sedang ☐ Berat ☐ Sesak		GCS: 456
Status Fisik			
Tanda Vital	TD : 137/84 mmHg Nadi : 146 x/mnt Suhu : 36 RR : 21 x/mnt		
Kondisi Nutrisi	☐ Obesitas ☐ Overweight ☒ Normoweight ☐ Underweight		
Kepala / Leher: Anemis : -/- Ikterik : -/- Cyanosis : -/- Dyspnue : -/- Pembesaran KGB : -/- Thorax: Gerak simetris (+), retraksi (-), normochest Cor : S1/S2 tunggal, reguler (+), gallop (-), murmur(-) Pulmo : Vesikuler : +/+, Rhonki : -/-, Wheezing : -/- Abdomen: Soefl (+), BU(+) N, meteorismus (-), Nyeri tekan -/-/- -/-/- -/-/- Hepar : tidak teraba Lien : tidak teraba Ekstremitas: Akral hangat, CRT <2 Edema -/- -/-			
Pemeriksaan Penunjang			
Laboratorium	Radiologi	Pemeriksaan Lainnya	
-	-	-	
Diagnosis Medis Utama: status epileptikus			

Permasalahan			
Medis	kontrol post mrs nyeri kepala sakala 4 kejang kejang		
Keperawatan	Gangguan Integritas Kulit/Jaringan # Gejala dan tanda Minor: * Objektif: - Nyeri		
Rencana Asuhan (Terapi / Instruksi / Standing Order / Intervensi)			
CITICOLINE TAB 500 MG - OGB MAHAKAM No. XV S2dd1 sesudah makan,Rute: Oral tx lanjut			
Tolok ukur/ Sasaran yang akan dicapai: tidak ada			
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)			
Telah dilakukan edukasi tentang Pengkajian Awal Medis kepada: ☒ Pasien ☐ Keluarga pasien, nama: Hubungan dengan pasien: ☐ Tidak dapat memberi edukasi kepada pasien atau keluarga Karena	Pasien  ABD JALIL	Keluarga	Dokter  dr. Fendi Fatkhurrohman Gozi Sp, BS SIP. 446/SIP-DS/196/424.072/



PENGKAJIAN AWAL MEDIS PENYAKIT DALAM

Riwayat Alergi	☒ Tidak ☐ Ya: Tidak Ada	
Kunjungan	Tanggal : 08-05-2025 Pukul : 07:33 WIB	
Anamnesis	☒ Auto anamnesis ☐ Allo anamnesis	
Anamnesis		
Keluhan Utama	kaki bengkak , batuk batuk , sesak sesak . TD = 154/85	
Riwayat Penyakit	Tidak Ada	
Riwayat Penggunaan Obat	Tidak Ada	
Kondisi Umum	☒ Sakit Ringan ☐ Sedang ☐ Berat ☐ Sesak GCS: 456	
Status Fisik		
Tanda Vital	TD : 154/85 mmHg Nadi : 106 x/mnt Suhu : 36,6 RR : 22 x/mnt	
Kondisi Nutrisi	☐ Obesitas ☐ Overweight ☒ Normoweight ☐ Underweight	
Kepala / Leher:	Anemis : -/- Ikterik : -/- Cyanosis : -/- Dyspnue : -/- Pembesaran KGB : -/- Thorax: Gerak simetris (+), retraksi (-), normochest Cor : S1/S2 tunggal, reguler (+), gallop (-), murmur(-) Pulmo : Vesikuler : +/+, Rhonki : -/-, Wheezing : -/- Abdomen: Soefl (+), BU(+) N, meteorismus (-), Nyeri tekan -/-/- -/-/- -/-/- Hepar : tidak teraba Lien : tidak teraba Ekstremitas: Akral hangat, CRT <2 Edema -/- -/-	
Pemeriksaan Penunjang		
Laboratorium	Radiologi	Pemeriksaan Lainnya
-	-	-
Diagnosis Medis Utama: Sindrom nefrotik		

Permasalahan			
Medis	kaki bengkok , batuk batuk , sesak sesak . TD = 154/85		
Keperawatan	Gangguan Penyapihan Ventilator # Gejala dan tanda Minor: * Subjektif: - Fokus meningkat pada pernafasan.		
Rencana Asuhan (Terapi / Instruksi / Standing Order / Intervensi)			
METHYLPREDNISOLONE TAB 16 MG - OGB NOVELL No. XXI S3dd1 sesudah makan,Rute: Oral, Ket lain: - CEFIXIME 200 MG - OGB DEXA No. XIV S2dd1 sesudah makan,Rute: Oral, Ket lain: - SPIRONOLACTONE TAB 100 MG - OGB DEXA No. VII S1/2-1/2-0 sesudah makan,Rute: Oral, Ket lain: - FUROSEMIDE TAB 40 MG - YARINDO No. VII S1-0-0 sesudah makan,Rute: Oral, Ket lain: - SIMVASTATIN TAB 20 MG - HEXPHARM JAYA No. XIV S0-0-2 sesudah makan,Rute: Oral, Ket lain: - ACETYLCYSTEINE CAPS 200 MG No. XV S3dd1 sesudah makan,Rute: Oral, Ket lain: - RAMIPRIL TAB 10 MG - OGB NOVELL No. VII S1-0-0 sesudah makan,Rute: Oral, Ket lain: - kontrol			
Tolok ukur/ Sasaran yang akan dicapai: keluhan membaik			
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)			
Telah dilakukan edukasi tentang Pengkajian Awal Medis kepada: ☒ Pasien ☐ Keluarga pasien, nama: Hubungan dengan pasien: ☐ Tidak dapat memberi edukasi kepada pasien atau keluarga Karena	Pasien  MOH. SHOFIUDDIN	Keluarga	Dokter  dr. Dimas Aryo Pamungkas Sp.PD SIP. 446/SIP-DS/137/424.072/